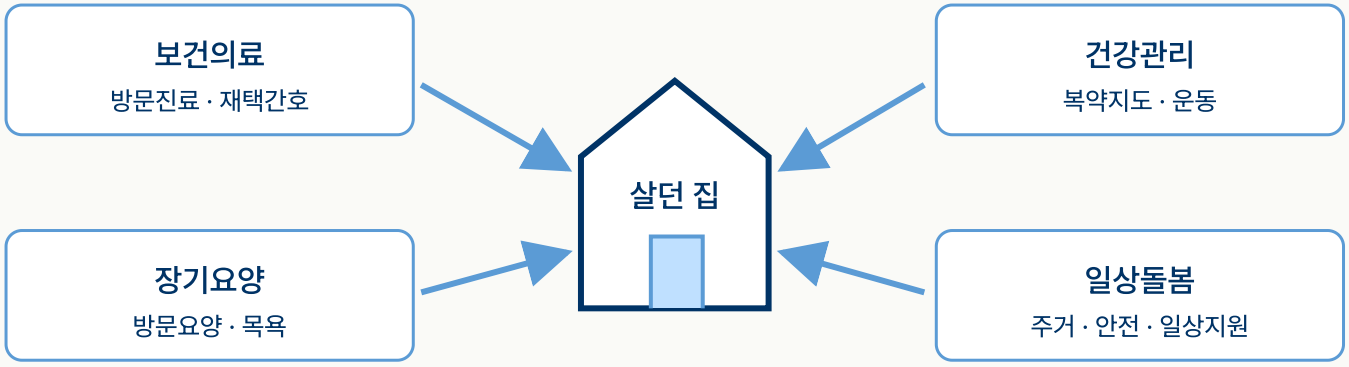
집에서 지내기 어려워졌다면, 돌봄도 진료에서 이야기하세요

검사 수치가 괜찮아도 식사·이동·목욕·복약을 혼자 해내기 어려울 수 있습니다. 생활의 어려움을 함께 살핍니다.

통합돌봄은 생활의 여러 영역을 잇습니다



통합돌봄은 살던 곳에서 건강한 생활을 이어가도록 보건의료·건강관리·장기요양·일상돌봄을 연결합니다.

통합돌봄과 장기요양보험을 구분합니다

제도	강의에서 설명한 역할·대상
지역사회 통합돌봄	**2026년 3월 27일** 시행된 제도로 설명했습니다. 노쇠·장애·질병으로 복합적인 도움이 필요한 사람에게 여러 서비스를 잇습니다.
통합돌봄 우선 대상	입원·입소 경계의 **65세 이상**, 장기요양 재가급여자(**1~5등급·인지지원등급**), 등급외자·노인맞춤돌봄 중점군·퇴원환자 등이 소개됐습니다.
장기요양보험	일상생활을 독립적으로 하기 어려운 **65세 이상** 또는 **65세 미만 노인성 질병**이 있는 사람이 조사·등급 판정을 거쳐 급여를 이용하는 제도입니다.

가족과 함께 정리할 생활의 어려움

1. 식사 준비·식사량, 목욕·옷 입기·화장실 이동에 도움이 필요한가요?
2. 약을 챙기거나 주사를 맞는 데 어려움이 있나요?
3. 넘어짐·어지럼, 기억력·기분 변화, 혼자 지내는 시간과 돕는 사람을 알립니다. CFS는 노쇠 상태를 살피는 임상 도구입니다. 개인별 서비스는 조사와 지원계획에 따라 연결됩니다.

광교바른내과 의원
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
평일(월–금) 08:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

신청부터 조사·계획·연계까지, 필요한 도움을 구체적으로

통합돌봄은 읍면동 행정복지센터나 국민건강보험공단 지사에 신청하는 경로가 강의에 소개되었습니다.

통합돌봄의 다섯 단계

1. **신청** · 읍면동·시군구, 공단 등에서 접수
2. **조사** · 의료·요양·돌봄 필요도를 함께 조사
3. **계획** · 개인별 지원계획과 통합지원회의
4. **연계** · 필요한 의료·요양·생활 서비스를 연결
5. **모니터링** · 상태 변화에 맞춰 계획을 조정

장기요양 신청 때의 흐름

국민건강보험공단에 본인 또는 대리인이 신청

교재는 방문·우편·팩스·인터넷 신청을 소개합니다. **65세 이상**은 장기요양인정신청서 제출 후 공단 방문조사와 의사소견서 절차를, **65세 미만**은 노인성 질병이 기록된 의사소견서를 함께 제출하는 절차를 제시했습니다. 이후 조사·판정으로 등급을 정합니다.

어떤 도움을 연결할 수 있나요?

영역	강의에서 소개한 서비스 예
보건의료 · 건강관리	방문진료·정신건강·치매·퇴원환자 지원, 재택간호, 복약지도·노쇠예방·운동 프로그램
장기요양 재가급여	방문요양·방문목욕·방문간호, 주야간보호·단기보호, 영양·재활·병원동행
일상돌봄	긴급돌봄, 독거노인 응급안전, 주거환경 개선·스마트홈 돌봄

등급은 신청 후 조사·판정으로 정합니다

연자는 **CFS 5~6점**이면 요양·돌봄의 필요를 적극적으로 살펴 연계하자고 설명했습니다.

광교바른내과 의원
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
평일(월–금) 08:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/geriatrics/integrated-home-care-asan28/